



PCSU

1. Examen des lieux

2. Évaluation primaire

3. Évaluation secondaire

4. Continuité des soins

1. EXAMEN DES LIEUX

Nature de l'intervention : médical ou trauma

Évaluer les dangers → **Protection**

Nombre de blessé(s) → **Renfort au besoin**

Mécanisme de blessure → **Protect. spinale**

Besoin(s) particulier(s) → **Police, Pompiers**

S'identifier et obtenir le consentement

Degré de conscience : **A-V-P-U (AVDI)**

SI URGENCE → 911

2. ÉVALUATION PRIMAIRE

C

- Arrêter saignements importants seulement

- Inconscient : **911** + prise pouls carotidien

Si pouls absent ou incertain → RCR

A

Airway / Voies respiratoires

- Ouvrir et dégager

- Sang, objet, sécrétion, œdème

- Stridor = obstruction dans les VR

B

Breathing / Respiration

- Qualifier la respiration

- Fréquence, régularité, amplitude

C

Circulation

- Conscient : prise de pouls radial

- Fréquence, régularité, amplitude

- État de la peau

- Coloration, température, texture

D

Désordre neurologique

- Orientation

- Identité, temps, lieux (3 sphères)

E

Exposer / Examen corps (30 sec)

- Déceler hémorragie interne et déformation

- Rechercher dispositif d'alerte médical

- Retirer de l'environnement chaud ou froid

- Appliquer une couverture, au besoin

SIGNES VITAUX

Âge	Fréquence respiratoire	Pouls	TA systolique
Adulte	12-20	60-100	100-140
6 à 12	18-25	75-120	95-115
1 à 6	20-40	80-140	85-115
< 1	30-55	100-190	70-105
N-Né	30-60	100-205	60-80

Saturation en oxygène (SpO₂)

Normale : 94-100 %

MPOC : 88-92 %

Glycémie capillaire

Normale : 4.0-7.0 mmol/L

Température

Hypothermie : < 35 °C / 95 °F

Normale : 35-38 °C

Fièvre : > 38 °C / 100.4 °F

Taille des pupilles

Myosis : ≤ 2 mm

Normale : 3-4 mm

Mydriase : ≥ 5 mm

État de la peau

Chaude, rosée et sèche

4. CONTINUITÉ DES SOINS

Réexaminer continuellement l'état de la victime et l'efficacité des soins administrés afin de la maintenir dans le meilleur état possible

• **ABC** et signes vitaux

Stable : aux 15 min

Instable : aux 5 min

• **Poursuivre soin(s) pour état de choc**, si applicable

Traiter la cause de l'état de choc

Prévenir la perte de chaleur corporelle

Normotendu : positionner selon confort

Hypotendu : décubitus dorsal, si toléré

• **Valider l'efficacité des traitements** en cours

• **Continuer à soutenir les blessures**, si applicable

Attelle : révéfier circulation, motricité et sensibilité

• **Noter l'évolution** de la victime + soins administrés

• **Préparer le transfert d'information** aux paramédics

• **Sécuriser les effets personnels** de la victime

DÉTÉRIORATION → REFAIRE 911

DVR – RA – RCR

OBSTRUCTION GRAVE DES VR

Conscient

Nourrisson

5 tapes dos + 5 poussées thoraciques

Enfant / Adulte

5 tapes dos + 5 poussées abdominales

* Enceinte / corpulent : poussées thoraciques

Inconscient

RCR (30:2) + Regarder dans la bouche avant les 2 ventilations

RESP. ARTIFICIELLE/ASSISTÉE

Pédiatrie FR < 10/min

1 ventilation aux 2 à 3 sec

Adulte FR < 8/min

1 ventilation aux 6 sec

Vérifier le pouls à toutes les 2 min (haut risque d'ACR)

RCR (ratio compressions : insufflations)

Secouriste	Nourrisson / Enfant	Adulte
Seul	30 : 2	30 : 2
2 ou plus	15 : 2	30 : 2

100 à 120 compressions / min – Changer aux 2 min

APPEL 911 PRIORITAIRE

OXYGÉNOTHÉRAPIE

Généralités

SpO₂ ≥ 94% : Ne pas administrer d'oxygène

SpO₂ < 94% : Viser satur. entre 94% et 98%

Si aucune mesure de saturométrie disponible (SpO₂), administrer de l'oxygène à haute concentration en cas de :

- Convulsions actives
- Difficulté respiratoire
- Degrés de conscience V-P-U
- État de choc

Utiliser un masque à haute concentration, peu importe la valeur de SpO₂, dans les situations suivantes :

- Inhalation de substance toxique
- Accident de plongée

Particularité

Chez la clientèle atteinte de **MPOC**, viser le confort et une SpO₂ entre 88% et 92%

* Bronchite chronique et/ou emphysème

MÉDICAMENTS

Généralités

Au Qc, il est légalement autorisé d'administrer l'épinéphrine ou la naloxone à une victime, connue ou non pour ces urgences. Au sein des SAC d'ASJ, l'auto-injecteur/vaporisateur doit être fourni par la victime, l'ASJ ou l'événement.

Il est interdit de suggérer la prise de tout autre médicament. Cependant, vous êtes autorisés à offrir votre assistance à une victime désirant prendre **ses propres médicaments**.

6 BONS

Bonne personne

Nom et prénom sur l'étiquette

Bon médicament

Nom du médicament, date d'expiration et son aspect

Bonne dose

Doit respecter la posologie ou les critères d'inclusion

Bon moment

Heure fixe ou au besoin? Fréquence? Répétable?

Bonne façon

Avaler? Croquer? Inhalation? Intranasal? Injectable?

Bonne consignment (documenter)

Heure, médicament, posologie, raison et évolution

RAPPORT VERBAL

S

Situation

- Nom, sexe, âge
- Plainte principale

B

Background / Antécédents

- Antécédents médicaux
- Médicaments
- Résumé de l'histoire

A

Assessment / Évaluation

- Résultat de l'examen physique
- Signes vitaux
- Soins administrés et évolution
- Inquiétude envers la victime?

R

Recommandation

- Répéter raison demande d'aide
- Toute information pertinente

CANULES

Facilitent le dégagement des voies respiratoires supérieures

NASOPHARYNGÉES

Victime avec altération de l'état de conscience

Mesure :
Pointe du nez
au lobe de l'oreille

Astuce :
Favoriser la 1^{ère} insertion dans la narine droite

OROPHARYNGÉES

Victime totalement inconsciente

Mesure :
Coin de la bouche
au lobe de l'oreille

Retirer si réflexe de vomissement présent

OXYGÉNOTHÉRAPIE (suite)

Débit d'oxygène selon l'outil utilisé

Lunettes nasales	1 à 6 L/min
Masque à haute concentration*	10 à 15 L/min
Masque de poche	10 à 15 L/min
Ballon-masque*	10 à 15 L/min

SATUROMÉTRIE

Facteurs pouvant fausser la lecture :

- Grande lumbosité ambiante
- Mouvements importants
- Mauvaise application du capteur
- Vernis à ongles et faux ongles
- Inhalation de certaines substances (ex. CO)
- Mauvaise perfusion des extrémités
- État de choc
- Certaines maladies
- Certains médicaments

APPELER RAPIDEMENT 911

GLUCOSE

Critères d'inclusion

• Glycémie < 4 mmol/L

Critères d'exclusion

• Alerte et capable d'évaluer sécuritairement

Posologie

Sugérer la prise de 15 à 20g de sucre tel que :

- Solution glucosée (Insta-Glucose^{MD}, Dex4^{MD})
- ½ tasse de jus ou boisson gazeuse
- 5 sachets de sucre blanc dans de l'eau
- 1 c. à soupe miel, sirop d'érable ou confiture

Remesurer la glycémie aux 15 min- Si critères toujours présents : répéter 1 fois
- Si persistance après 2 doses : composer 911

Particularités

En présence de signes et symptômes compatibles avec une urgence diabétique, s'il est impossible de mesurer la glycémie, suggérer la prise de sucre.

Lorsque la glycémie est corrigée, encourager la victime à manger un repas contenant des glucides **ET** des protéines afin d'éviter une récidence de l'hypoglycémie.

NUMÉROS UTILES

Ambulance – Police – Pompiers : 911

Info santé – Info sociale : 811

Centre antipoison : 1 (800) 463-5060

Ressources communautaires : 211

Ambulance Saint-Jean : 1 (800) 706-6660

Contact d'urgence : _____

Responsable ASJ : _____

Cet aide-mémoire appartient à _____

Nom : _____

No provincial : _____

DEGRÉ DE CONSCIENCE

Le degré de conscience évalue la capacité de la victime à réagir aux stimulus externes

A	ALERTE	Yeux ouverts et visiblement conscient
V	VERBAL	Sommeil et doit être stimulé verbalement
P	PAIN	Réagit uniquement à une stimulation douloureuse
U	UNRESPONSIVE INCONSCIENT	Ne réagit pas à aucune stimulation

I

D

3. ÉVALUATION SECONDAIRE

HISTORIQUE

S	Signes et symptômes
A	Allergies
M	Médicaments (suppléments, produits naturels)
M	Maladies antérieures
D	Dernière prise (repas, hydratation, alcool, drogue)
E	Événement déclencheur

Un SAMME par victime

Un OPQRST par symptôme

S	Signes et symptômes
A	Allergies
M	Médicaments (suppléments, produits naturels)
M	Maladies antérieures
D	Dernière prise (repas, hydratation, alcool, drogue)
E	Événement déclencheur

Un SAMME par victime

Un OPQRST par symptôme

O	Début (Onset)
P	Provocation
Q	Qualité
R	Région
S	Sévérité
T	Temps

Un SAMME par victime

Un OPQRST par symptôme

ÉCHELLE DE GLASGOW (GCS)

Prioriser l'échelle AVPU (AVDI). Utiliser GCS lorsque plus de précision nécessaire (trauma crânien, AVC, etc.)

Notez la meilleure réponse pour chaque catégorie

OUVERTURE	DES YEUX	RÉPONSE VERBALE	RÉPONSE MOTRICE	TOTAL
4 Spontanée	3 À la parole	5 Orientée X3	6 Obéit aux ordres	Y _ + V _ + M _ = /15
2 À la douleur	3 Mots inappropriés	4 Conversation confuse	5 Localise la douleur	
1 Aucune ouverture	1 Aucune réponse audib	3 Mots inappropriés	4 Se retire à la douleur	
	2 Sons incompréhensibles	2 Sons incompréhensibles	3 Flexion du bras	
	1 Aucune réponse audib	1 Aucune réponse audib	2 Extension du bras	
			1 Pas de mouvement	

🔥

ÉPINÉPHRINE

Critères d'inclusion

Contact avec agent causal ≤ 4h

ET

- Détresse respiratoire **ou** hypotension

OU

- 2 des 4** présentations suivantes :
 - Urticaire ou angioedème
 - Difficulté respiratoire
 - Défaillance circulatoire
 - Symptômes gastro-intestinaux

Critère d'exclusion

- Aucun

Posologie

Auto-injecteur d'épinéphrine :

≥ 50 kg / 110 lbs : 0,5 mg IM (si disponible)

≥ 25 kg / 55 lbs (≥ 8 ans) : 0,3 mg IM

< 25 kg / 55 lbs (< 8 ans) : 0,15 mg IM

- Répéter aux 5 min si détérioration

- Répéter aux 10 min si présence de critères d'inclusion

- Répéter aux 10 min si absence d'amélioration

Site d'injection : tier médian du vaste externe (cuisse)

APPEL 911 PRIORITAIRE

🔥

AÉROSOL-DOSEUR

Lors de difficulté respiratoire, plusieurs victimes utilisent un bronchodilatateur à courte action pour soulager leurs symptômes.

La plupart utilisent une pompe bleue contenant du salbutamol (ex Airomir^{MD}, Ventolin^{MD}).

L'utilisation d'un tube d'espacement augmente l'efficacité de l'aérosol-doseur (ex Aerochamber^{MD}).

AVEC TUBE D'ESPACEMENT

- Agiter l'aérosol-doseur X3-5 sec et retirer le bouchon
- Insérer l'aérosol-doseur dans le tube d'espacement
- Expirer complètement
- Refermer les lèvres autour de l'embout buccal
- Appuyer une fois sur la cartouche
- Inspirer lentement et profondément par la bouche
- Retenir la respiration X5-10 sec
- Expirer normalement

*Si incapable de retenir son souffle, faire 4-6 cycles respiratoires dans le tube.

SANS TUBE D'ESPACEMENT

- Agiter l'aérosol-doseur X3-5sec et retirer le bouchon
- Expirer complètement
- Refermer les lèvres autour de l'embout buccal
- Inspirer lentement par la bouche
- Appuyez une fois sur la cartouche
- Continuer à inspirer lentement et profondément
- Retenir la respiration X 5-10 sec
- Expirer normalement

🔥

PROB. CARDIAQUE SUSPECTÉ

Suspecter une urgence cardiovasculaire si la victime présente :

- Douleur thoracique avec ou sans irradiation à la mâchoire, bras ou dos
 - Pression / pesanteur / constriction
 - Etouffement / Etou
 - Poing
 - Serrement
 - Indigestion / Inconfort
- Difficulté resp. ou faiblesse soudaine
- Signes et symptômes d'état de choc

En attendant l'ambulance

- Mettre la victime au repos, assurer le confort
- Mesurer les signes vitaux
- Pas O₂ d'emblée. Respecter protocole SpO₂
- S'assurer que le DEA est disponible
- Si la victime décide de prendre par **elle-même** sa propre médication (nitro et AAS), offrir de vérifier la présence de critères d'exclusion.

Particularités

Porter une attention particulière aux clientèles avec signes et symptômes moins évidents: femmes, personnes âgées, atteintes de diabète, etc.

APPEL 911 PRIORITAIRE

🔥

HYPERTHERMIE

CRAMPES MUSCULAIRES

Contraction musculaire douloureuse, incontrôlable, d'apparition brutale et de courte durée en contexte d'effort.

Premiers soins :

- Mettre la victime au repos dans un endroit frais
- Suggérer une solution de réhydratation, si requis
- Masser et étirer progressivement le muscle atteint

ÉPUISEMENT À LA CHALEUR

Lors de temps chaud, le débit cardiaque ne suffit plus à la demande du corps en raison d'une déshydratation et de la redistribution du sang vers la peau

Présentation clinique :

- Faiblesse et étourdissement
- Céphalée
- Nausées et vomissements
- Crampes musculaires persistantes
- Hypotension orthostatique
- Tachycardie, tachypnée
- Aucune perte de conscience ou convulsions**
- Aucune confusion franche**
- Température corporelle 38-40°C**

Premiers soins :

- Retirer de l'environnement chaud
- Refroidir la victime
- Suggérer une solution de réhydratation

🔥

HYPOTHERMIE

LÉGÈRE

Température corporelle : 32-35 °C

Présentation clinique :

- Grelotement présent
- Conscient
- Trouble de l'élocution
- Renfermé, indifférent, perte intérêt activité
- Pouls normal
- Respiration normale

MODÉRÉE

Température corporelle : 28-32 °C

Présentation clinique :

- Grelotement violent ou interrompu
- Désorienté, somnolent, irrationnel
- Démarche hésitante, maladroit
- Pouls lent et faible
- Respiration lente et faible

GRAVE

Température corporelle : < 28 °C

Présentation clinique :

- Grelotement interrompu
- Inconscient
- Pouls faible, irrégulier ou absent
- Respiration faible ou absente

🔥

COLLIER CERVICAL

- Maintenir la tête en position neutre
- Mesurer la taille du collier sur la victime
 - Main ouverte, pouce vers le haut
 - Repère inférieur : épaule (trapèze)
 - Repère supérieur : menton
- Ajuster le collier et le soutien de menton
 - Reporter le nombre de doigts sur les repères du collier.
 - Repère inférieur : bord plastique inférieur
 - Repère supérieur : indication de réglage le plus proche du doigt supérieur mesuré
- Verrouiller les ongles
- Préformer et installer le collier
 - Réajuster si non-toléré, assurer le confort

Ne pas lâcher la tête tant que la victime n'est pas complètement immobilisée sur une planche dorsale ou dans un matelas immobilisateur

🔥

GARROT

Critères d'utilisation

- Hémorragie importante d'un membre incontrôlable par une pression directe

OU

- Amputation partielle ou totale d'un membre (au-dessus poignet / cheville)

OU

- Hémorragie importante sur une victime requérant des interventions immédiates et prioritaires (RCR, RA, évacuation, etc.)

Sites

Le plus près possible du traumatisme :

- 4 doigts au-dessus (proximal) de la blessure
- 2 doigts au-dessus (proximal) d'une articulation

Si 2^e garrot nécessaire, mettre au-dessus du 1^{er}

Particularités

Appliquer directement sur la peau, si possible. Faire un très bon serrement initial. Laisser le garrot visible, noter l'heure d'application puis transmettre l'information aux paramédics. Administrer les soins continus pour état de choc. Ne jamais retirer ou desserrer le garrot.

APPEL 911 PRIORITAIRE

🔥

SINISTRE

ORGANISATION PHYSIQUE DES LIEUX

